

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Rabu / 15 Januari 2025
PUKUL : 14.00 – 16.00 WIB
JENIS MEETING : Rapat Internal Farmasi
TEMPAT : Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Rawat Inap Masalah : - Tidak ada etiket untuk cairan NS 1000 ml atau Steril Water, sehingga menimbulkan retur obat dari ruang rawat inap tidak ada nama ketika melakukan retur ke farmasi - Indikasi obat terlalu ilmiah - Retur obat ruang dari IRNA ke farmasi - Obat pasien rawat inap sering tertinggal di Farmasi untuk obat dari rumah - PR rekam medis untuk DPO pasien pulang → yang sering terjadi adalah pasien dengan tindakan operasi - Serah terima TTK dan perawat tidak lengkap Keterangan : - PIC : - Kepala Instalasi Farmasi - Apoteker Rawat Inap - Petugas Farmasi Rencana Tindak Lanjut : - Untuk cairan yang akan digunakan untuk tindakan operasi dari farmasi wajib memberikan label etiket. Etiket tidak boleh diberikan pada kardus dengan jumlah beberapa cairan hanya satu etiket di kardus saja. Lakukan telusur pemakaian cairan sesuai dengan inputan resep di SIMRS (peresepan dari IKO) - Penulisan indikasi pada etiket obat lebih di permudah untuk di mengerti oleh pasien - Retur obat ruang dari IRNA ke farmasi : dilakukan serah terima dengan perawat ruangan untuk menghindari selisih barang, dilakukan cek kesesuaian jumlah fisik dan SIMRS - Obat pasien rawat inap sering tertinggal di Farmasi untuk obat dari rumah : untuk obat dari rumah disertakan dengan form serah terima obat dari rumah yang diletakkan di keranjang pasien masing – masing pada ruang rawat inap (ruang obat), apabila pasien pulang di rentan pukul 08.00 – 16.00 sesuai dengan jam kerja apoteker rawat inap maka obat yang dilanjutkan diminum diberikan kepada petugas farmasi dan diberikan label cara pemakaian obat. Apabila pasien pulang di atas pukul 16.00 maka dilakukan oleh perawat. Untuk pengerjaan DPO dan visit oleh apoteker di prioritaskan pada pasien OB - PR rekam medis untuk DPO pasien pulang → yang sering terjadi adalah pasien dengan tindakan operasi : dengan pembagian pola jaga pada jadwal apoteker rawat inap. Penulisan rekonsiliasi obat pada pasien setelah operasi di ruang rekam medis - Koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan terkait update label pasien sesuai dengan jumlah pasien dan nama pasien
2	Pokok Bahasan : Rawat Jalan Masalah : - Waktu tunggu farmasi - PRB untuk pasien BPJS Kesehatan - Klaim untuk pasien rujukan 2 poli



4. Obat kosong yang tetap di resepkan oleh dokter 5. Penginputan e-resep pada pasien rawat jalan sering terjadi kesalahan dalam aturan pakai 6. Evaluasi monitoring stok pada pemakaian injeksi di poli rawat jalan 7. Kekosongan Spironolacton
Keterangan : -
PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Apoteker Rawat Jalan 3. Petugas Farmasi
Rencana Tindak Lanjut : 1. Untuk waktu tunggu farmasi dimulai dari pembagian petugas input terdiri dari 2 orang dan 1 orang lagi sebagai perbantuan apabila di perlukan, apabila input dan siap obat terjadi penumpukan maka yang didahulukan adalah siap obat. Pembagian PJ input dibagi oleh apoteker rawat jalan, setiap PJ input membawahi masing – masing 1 petugas farmasi baru yang belum bisa melakukan input dengan target 3 minggu petugas farmasi baru sudah bisa melakukan input 2. Akun PRB diajukan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan nama PIC terbaru dengan menunjuk 2 orang sebagai PIC PRB di Instalasi Farmasi PHS. Target PRB dan iterusasi tahun 2025 belum ada pemberitahuan 3. Klaim obat untuk rujukan 2 poli sesuai dengan tanggal retriksi obat pada sebelumnya, bisa menggunakan 2 nomor apol apabila tanggal berbeda (jangan lupa koordinasi dengan poli untuk kontrol selanjutnya), apabila dalam satu hari tersebut bisa kunjungan ke2 poli maka penginputan pada apol dijadikan satu. Contoh kasus : pasien A kontrol tgl 13/01/2025 ke poli IPD dan dilakukan konsul internal ke poli saraf pada tgl 14/01/2025 apabila pasien tidak ada teriksi tanggal tertentu maka obat bisa di inputkan di tanggal 13/01/2025, untuk penyimpanan resep sesuai dengan tanggal resep. Apabila ke poli IPD tanggal 13/01/2025 dan ternyata tanggal pengambilan obat saraf sebelumnya tgl 14/12/2024, maka penginputan obat pada apol bisa menggunakan 2 nomor apol dengan satu nomor SEP (nomor 1 untuk klaim obat dari IPD tgl 13/01/2025 dan nomor 2 tgl 14/01/2025 untuk klaim obat dari poli saraf) → akan ada surat edaran lebih lanjut dari manajemen RS terkait teknis konsul internal dan rujuk internal pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan. Pemberian obat kronis wajib disertakan dengan KPO 4. Obat kosong akan tetap bisa di resepkan oleh DPJP apabila DPJP tersebut menggunakan fitur copy resep pada SIMRS sudah korodinasi dengan programer obat akan tetap bisa di resepkan apabila master barang masih aktif. Kepala Instalasi melakukan verifikasi penghapusan nama obat pada rak obat apabila obat sudah tidak digunakan (berlaku pada saat stok opname) 5. Penginputan e-resep pada pasien rawat jalan sering terjadi kesalahan dalam aturan pakai maka perlu dilakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan Medis. Perlu koordinasi dengan programer terkait signa obat “dihapuskan pada poin signa 2 sebelum atau sesudah makan dihapus”. Apoteker membuat daftar list obat sebagai referensi untuk obat – obat dengan aturan pakai sesudah makan atau sebelum makan dan interaksi obat (Apt. Nabila & Apt. Ledyna) 6. Untuk pemakaian obat injeksi di rawat inap diberikan sesuai jumlah pada form, apabila injeksi habis maka diberikan lagi dengan form baru dan jumlah obat sesuai. Petugas farmasi wajib melakukan cek kesesuaian inputan dengan pemakaian pasien dan petugas farmasi bagian input melakukan cetak nota (obat injeksi dan vaksin) untuk di operkan di petugas berikutnya.



	7. Untuk spironolactone di infokan tersedia tanggal 17/01/2025 dari pabrik. Apabila di bulan Januari 2025 obat datang sebelum klaim maka obat diberikan ke pasien, apabila datang melebihi dari klaim diberangkatkan obat tidak diberikan ke pasien.
3	Pokok Bahasan : Depo Farmasi IGD dan IKO Masalah : 1. Penginputan obat SC yang tidak sesuai 2. Pemakaian masker pada perawat IGD 3. Ditemukan obat tidak bertuan di IGD 4. Kekosongan obat di IGD pada saat malam hari Keterangan : - PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Petugas Farmasi 3. Petugas IGD Rencana Tindak Lanjut : 1. Cek kesesuaian paket SC secara fisik dan form serah terima paket SC di SIMRS 2. Pemakaian masker di inputkan pada SIMRS → akan di koordinasikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik dengan IGD alasan kenapa tidak di inputkan ke pasien 3. Obat yang sudah tidak di pakai di IGD perawat wajib melakukan retur ke Depo farmasi IGD IKO sesuai dengan peresepan. Untuk saat ini yang sudah terlanjur obat tidak ada nama masing – masing pasien dibuatkan berita acara untuk dilakukan penyesuaian stok 4. Kekosongan obat – obat IGD <i>fast moving</i> di IGD tetap diusahakan permintaan ke gudang untuk mencegah mutasi antar depo yang membuat stok menjadi rancu. Akan ada google spreadsheet terkait pemantauan obat yang diambil ke gudang famasi diluar jam kerja gudang farmasi. Dilakukan pemecahan biling SIMRS laporan penjualan depo farmasi IGD dan IKO → koordinasi dengan programmer
4	Pokok Bahasan : Obat Tertinggal Masalah : 1. Terjadi kenaikan obat tertinggal di rawat jalan dan rawat inap 2. Sering tidak ada konfirmasi dari perawat rawat inap apabila pasien mendapatkan 2 resep obat pulang 3. Administrasi obat pulang belum selesai tetapi pasien sudah di arahkan untuk ambil obat 4. Peresepan dobel pada pemakaian insulin di rawat inap Keterangan : - PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Seluruh Petugas Farmasi 3. Petugas farmasi Keterangan : - Rencana Tindak Lanjut : 1. Pembaruan nomor telpon pasien di pendaftaran ketika pasien mendaftar agar memudahkan farmasi dalam menghubungi pasien apabila obat pasien di tinggal 2. Obat tertinggal dari rumah : obat dari rumah dibedakan menjadi 2 yaitu obat di lanjut dan obat tidak di lanjut. Untuk obat yang dilanjut disimpan di farmasi, untuk obat tidak dilanjut disimpan di ruang rawat inap (poin permasalahan di IRNA poin 3) 3. Perawat sebelum pasien di arahkan ke farmasi untuk melihat spreadsheet obat final terlebih dahulu, apabila ada 2 resep final maka perawat wajib konfirmasi ke farmasi → koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan



	4. Peresepan insulin apabila cukup sampai pasien kontrol ke rawat jalan, maka tidak perlu diresepkan lagi
5	Pokok Bahasan : Obat TBC Masalah : 1. Obat TBC masih pinjam di pasien lain tidak sesuai dengan box pasien 2. PIC Poli TB tidak melakukan update data pasien secara berkala sehingga stok obat tidak sesuai dengan jumlah pasien Keterangan : - PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Kepala Gudang Farmasi 3. Petugas Farmasi 4. PIC TBC di Farmasi Rencana Tindak Lanjut : 1. Apabila terdapat kekosongan obat TBC dan di pinjamkan di pasien lain, maka wajib konfirmasi kepada PIC TBC (Apt. Via) dan segera dilakukan permintaan ke DINKES untuk mengganti obat yang sudah di pinjam tersebut 2. Koordinasi dengan perawat PIC Poli TBC dan untuk sementara waktu apabila belum dilakukan update data maka menggunakan data pasien lama untuk permintaan obat ke DINKES
7	Pokok Bahasan : PPI Masalah : 1. Obat obat dengan rekonstitusi perlu diberikan BUD Keterangan : - PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Apoteker Rawat Inap 3. Perawat IRNA Rencana Tindak Lanjut : 1. Diberikan label untuk obat yang dilakukan rekonstitusi BUD 2. Panduan terkait rekonstitusi BUD obat (Apt. Ladyna) 3. Perawat wajib melakukan pengoplosan obat di ruang LAF
8	Pokok Bahasan : Mutu Masalah : 1. indikator mutu tahun 2025 2. Pelabelan LASA dan <i>high alert</i> tidak berjalan 3. link survey kepuasan pasien terlalu panjang sehingga pasien tidak mengisi Keterangan : - PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. PJ Mutu Rencana Tindak Lanjut : 1. Melakukan pelatihan untuk pelaporan mutu 2. Indikator mutu tahun 2025 menunggu hasil rapat kerja tahun 2025 3. Pelabelan LASA dan <i>high alert</i> dilakukan setelah serah terima dari gudang atau sebelum diberikan kepada perawat atau pasien 4. Link survey kepuasan pasien dilakukan pemecahan setiap unit
9	Pokok Bahasan : HIV

	Masalah : Kekosongan obat HIV dan permintaan sering dikurangi oleh pihak DINKES
	Keterangan : -
	PIC : - Kepala Instalasi Farmasi - Kepala Gudang Farmasi - PJ HIV
	Rencana Tindak Lanjut : - Permintaan obat dilakukan 1 bulan sekali - Penambahan PJ HIV ditambahkan dengan Kepala Gudang Farmasi agar lebih mudah dalam monitoring obat HIV - Untuk obat hibah dari DINKES Vitamin B6, Rifampicin, Cotrimoxazole hanya boleh diberikan kepada pasien TBC atau HIV tidak masuk dalam klaim obat apotek online - PJ HIV membuatkan daftar list obat yang digunakan pada pasien HIV dan tidak boleh digunakan oleh pasien lain - Permintaan dilebihkan sebagai buffer stok di gudang farmasi
10	Pokok Bahasan : Dokumen
	Masalah : Sentralisasi Dokumen yang ada di Farmasi
	Keterangan : -
	PIC : - Instalasi Farmasi - PJ Dokumen
	Rencana Tindak Lanjut : - Untuk pengarsipan resep dilakukan 2x dalam satu minggu. Dilakukan setiap hari Senin dan Kamis oleh petugas shift midle - Permintaan softfile ke unit Rekam Medis untuk pembaruan - Seluruh dokumen Farmasi dalam bentuk softfile dilakukan penyimpanan di Gdrive - Seluruh dokumen Farmasi dalam bentuk hardfile dijadikan satu dalam satu rak dan dibuatkan map diberikan nama - Penertiban petugas farmasi terkait tempat dokumentasi wajib seluruh petugas farmasi paham
11	Pokok Bahasan : PKRS
	Masalah : Edukasi pasien
	Keterangan : -
	PIC : PJ PKRS
	Rencana Tindak Lanjut : - Target untuk edukasi ke pasien dalam satu bulan dilakukan minimal 4x - Pembagian jadwal untuk melakukan edukasi di Instalasi Farmasi dibagi sesuai dengan tim dan jam dinas petugas
12	Pokok Bahasan : PPRA
	Masalah : Pelaporan Tahun 2024 dan kesulitan pengambilan data di rawat jalan
	Keterangan : -
	PIC : PJ PPRS

	Rencana Tindak Lanjut : 1. Pelaporan tahun 2024 penyusunan koordinasi dengan PPRA di RS Prima Husada Malang 2. Untuk pelaporan penggunaan antibiotik ditambahkan pada pemakaian di Rawat Jalan (koordinasi dengan apoteker rawat jalan) 3. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengambilan data di rawat jalan
13	Pokok Bahasan : Gudang Farmasi
	Masalah : Pengambilan diluar jam kerja gudang farmasi
	Keterangan : -
	PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Kepala Gudang Farmasi 3. Petugas Farmasi
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Seluruh pengambilan obat ke gudang farmasi diluar jam kerja gudang farmasi wajib melakukan konfirmasi kepada petugas gudang 2. Petugas farmasi melakukan pengambilan obat disertai dengan foto fisik dan kartu stok dan foto dari permintaan di SIMRS yang besoknya akan di cek oleh petugas gudang 3. Untuk depo IGD IKO apabila melakukan pengambilan obat dalam bentuk satuan terkecil maka mengambil dalam box obat yang sudah diberikan label oleh petugas gudang 4. Untuk pereturan obat bertuan yang biasa dilakukan di tanggal 20, maka per bulan ini dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan dijadwalkan minimal 2x periode
14	Pokok Bahasan : K3RS
	Masalah : Label B3 masih belum berjalan
	Keterangan : -
	PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. PJ K3RS
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Penertiban petugas gudang sebelum dilakukan serah terima ke unit harus disertai label dengan ketentuan B3

Pemimpin Rapat



(Apt. Laili Choiru Umma, S. Farm)

Pasuruan, 15 Januari 2025

Notulis



(Dina Ulyana, SE)

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS)

Dokumentasi



NOTULEN

HARI / TANGGAL : Rabu / 15 Januari 2025
 PUKUL : 14.00 – 16.00 WIB
 JENIS MEETING : Rapat Internal Farmasi
 TEMPAT : Instalasi Farmasi RS Prima Husada Sukorejo

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Rawat Inap Masalah : 1. Tidak ada etiket untuk cairan NS 1000 ml atau Steril Water, sehingga menimbulkan retur obat dari ruang rawat inap tidak ada nama ketika melakukan retur ke farmasi 2. Indikasi obat terlalu ilmiah 3. Retur obat ruang dari IRNA ke farmasi 4. Obat pasien rawat inap sering tertinggal di Farmasi untuk obat dari rumah 5. PR rekam medis untuk DPO pasien pulang → yang sering terjadi adalah pasien dengan tindakan operasi 6. Serah terima TTK dan perawat tidak lengkap Keterangan : - PIC : 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Apoteker Rawat Inap 3. Petugas Farmasi Rencana Tindak Lanjut : 1. Untuk cairan yang akan digunakan untuk tindakan operasi dari farmasi wajib memberikan label etiket. Etiket tidak boleh diberikan pada kardus dengan jumlah beberapa cairan hanya satu etiket di kardus saja. Lakukan telusur pemakaian cairan sesuai dengan inputan resep di SIMRS (peresepan dari IKO) 2. Penulisan indikasi pada etiket obat lebih di permudah untuk di mengerti oleh pasien 3. Retur obat ruang dari IRNA ke farmasi : dilakukan serah terima dengan perawat ruangan untuk menghindari selisih barang, dilakukan cek kesesuaian jumlah fisik dan SIMRS 4. Obat pasien rawat inap sering tertinggal di Farmasi untuk obat dari rumah : untuk obat dari rumah disertakan dengan form serah terima obat dari rumah yang diletakkan di keranjang pasien masing – masing pada ruang rawat inap (ruang obat), apabila pasien pulang di rentan pukul 08.00 – 16.00 sesuai dengan jam kerja apoteker rawat inap maka obat yang dilanjutkan diminum diberikan kepada petugas farmasi dan diberikan label cara pemakaian obat. Apabila pasien pulang di atas pukul 16.00 maka dilakukan oleh perawat. Untuk pengerjaan DPO dan visit oleh apoteker di prioritaskan pada pasien OB 5. PR rekam medis untuk DPO pasien pulang → yang sering terjadi adalah pasien dengan tindakan operasi : dengan pembagian pola jaga pada jadwal apoteker rawat inap. Penulisan rekonsiliasi obat pada pasien setelah operasi di ruang rekam medis 6. Koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan terkait update label pasien sesuai dengan jumlah pasien dan nama pasien
2	Pokok Bahasan : Rawat Jalan Masalah : 1. Waktu tunggu farmasi 2. PRB untuk pasien BPJS Kesehatan 3. Klaim untuk pasien rujukan 2 poli